

Si vous envisagez une chirurgie pour un prolapsus des organes pelviens, plusieurs choix s'offrent à vous en concertation avec votre chirurgien. Il n'y a généralement **pas de « bonne » réponse unique** — le meilleur plan dépend de votre anatomie, de votre état de santé et de vos priorités. Cette fiche passe en revue les principales décisions afin que vous puissiez avoir une conversation éclairée.

Les principales décisions

- **Réparation ou fermeture** — reconstruire le soutien (reconstructive) en conservant le vagin ouvert, ou fermer le vagin (colpoclis) si vous ne prévoyez pas de rapports sexuels vaginaux.
- **Voie d'abord** — voie vaginale, ou voie abdominale par coelioscopie/chirurgie robotique.
- **Votre utérus** — le retirer (hystérectomie) ou le conserver avec une suspension de l'utérus (hystéropexie).
- **Matériau de soutien** — vos propres tissus natifs, une greffe biologique, ou une bandelette/trellis synthétique (par exemple sacrocolpopexie par voie abdominale).
- **Fuites urinaires** — ajouter ou non un geste anti-fuites pendant la même intervention (voir ci-dessous).

Les fuites urinaires cachées

Un prolapsus volumineux peut **masquer** une incontinence urinaire d'effort qui n'apparaît qu'après la correction du prolapsus (incontinence « occulte »). Votre équipe peut tester ce phénomène et discuter de l'opportunité de poser une bandelette (sling) en même temps ou d'attendre.

COMPRENDRE LES TERMES

Reconstructive

Reconstruire le soutien en conservant le vagin fonctionnel.

Oblitérante

Fermeture du vagin (colpoclis) — très durable, met fin aux rapports sexuels.

Hystéropexie

Suspension de l'utérus sans le retirer.

Réparation par tissus natifs

Chirurgie utilisant uniquement vos propres tissus, sans greffe.

Incontinence occulte

Fuite urinaire cachée qui apparaît une fois le prolapsus corrigé.

Récidive

Risque que le prolapsus réapparaisse avec le temps.

COMMENT CHOISIR ? En faisant correspondre les options à **vos** priorités — durabilité, temps de récupération, conservation de l'utérus, activité sexuelle et ressenti vis-à-vis du treillis synthétique. Votre chirurgien recommandera ce qui convient à votre anatomie ; la « meilleure » option est celle qui s'aligne avec vos objectifs après une discussion claire.

Questions à poser à votre chirurgien

- Quelle(s) **intervention(s)** me recommandez-vous, et pourquoi ?
- **Voie vaginale ou abdominale** — et à quoi ressemble la récupération pour chacune ?
- Puis-je (ou devrais-je) **conserver mon utérus** ?
- Utiliserez-vous **mes propres tissus, une greffe ou une bandelette synthétique** — et quels sont les risques ?
- Ai-je besoin d'un geste **anti-fuites** maintenant ou plus tard ?
- Quel est le risque de **récidive**, et que se passe-t-il si le prolapsus revient ?

À savoir également

- Un **pessaire** est toujours une alternative non chirurgicale si vous préférez éviter ou reporter l'opération.
- Contrôler le poids, la constipation, la toux chronique et (après la ménopause) utiliser un œstrogène vaginal peut améliorer les résultats.

Avant l'intervention

- Effectuez les **bilans préopératoires** et apportez la liste complète de vos médicaments.
- Prévoyez d'**arrêter de fumer** et organisez une aide à domicile.
- Règle générale : éviter les efforts lourds et les rapports sexuels pendant ~6 semaines.

Signalez à votre équipe avant l'opération si vous :

- Prenez un **anticoagulant** ou avez un trouble de la coagulation
- Avez une **infection** urinaire ou vaginale en cours
- Avez de nouvelles **douleurs pelviennes, des saignements ou une plaie qui ne cicatrise pas** sur la bosse du prolapsus

TROIS CHOSES À RETENIR

1. La chirurgie du prolapsus implique plusieurs choix — réparation ou fermeture, voie d'abord, conservation de l'utérus, matériau de soutien et traitement des fuites cachées.
2. Il n'y a rarement qu'une seule bonne réponse ; le meilleur plan correspond à votre anatomie et à vos priorités.
3. Posez les questions essentielles et n'oubliez pas qu'un pessaire est toujours une alternative sans chirurgie.